BULLETIN HEBDOMADAIRE · VEILLE EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

PAUSE AR ||

Nouveautés de la semaine du 31 octobre 2026

5 nouveautés cette semaine, dont 1 susceptible de changer votre pratique.

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION PÉDIATRIQUE Essai randomisé · PROSpect

Prone positioning and high-frequency oscillatory ventilation in early paediatric acute respiratory distress syndrome (PROSpect): an international, two-by-two factorial, response-adaptive, phase 3, randomised controlled trial

Lancet · 31 octobre 2026 · Essai randomisé de phase 3 à plan factoriel, arrêté à 424 enfants sur 600 prévus, 75 réanimations pédiatriques

Le décubitus ventral et la ventilation par oscillations à haute fréquence sont utilisés de façon très variable dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, faute de données concluantes. Cet essai a comparé le décubitus ventral au décubitus dorsal, et les oscillations à haute fréquence à la ventilation conventionnelle, selon un plan factoriel deux par deux qui rend les deux comparaisons indépendantes l'une de l'autre ; il a porté sur des enfants de deux semaines à vingt ans, ventilés depuis moins de 96 heures pour une forme modérée à sévère, dans soixante-quinze réanimations pédiatriques de dix-huit pays. Il a été arrêté avant son terme, après l'inclusion de 424 enfants sur les 600 prévus, pour futilité et pour lenteur du recrutement : sur le critère principal — les jours vivant sans ventilation à vingt-huit jours —, aucune des deux stratégies n'a fait mieux que son comparateur. Trois complications ont en revanche été plus fréquentes : obstruction de sonde et escarres sous décubitus ventral, instabilité hémodynamique sous oscillations. L'essai conclut qu'aucun argument ne soutient ces deux stratégies en première intention et que leur usage courant n'est pas recommandé dans cette population.

> **En pratique :** chez l'enfant ventilé pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë modéré à sévère, le mettre d'emblée en décubitus ventral ou passer aussitôt aux oscillations à haute fréquence n'a pas augmenté les jours vivant sans ventilation, et aucune différence de mortalité à vingt-huit jours n'est apparue. Les trois signaux défavorables — obstruction de sonde et escarres sous décubitus ventral, instabilité hémodynamique sous oscillations — ne sont pas anodins chez un enfant intubé. La conclusion de l'essai est explicite : les auteurs écrivent que l'usage courant de ces deux stratégies dans cette population n'est pas recommandé. Arrêté avant son terme, l'essai établit une absence de bénéfice démontré et non l'équivalence des stratégies, et ne dit rien du décubitus ventral employé en recours devant une hypoxémie qui résiste.

Article original

ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE & DOULEUR Essai randomisé

Effects of perioperative esketamine infusion on chronic pain after video-assisted thoracoscopic lung resection: a multicentre, randomised, double-blind clinical trial

Br J Anaesth · 28 octobre 2026 · Essai randomisé multicentrique en double aveugle, 873 patients analysés

La douleur chronique après chirurgie thoracoscopique reste fréquente. Cet essai a comparé l'eskétamine au sérum salé chez 914 adultes tirés au sort, dont 873 analysés, opérés d'une résection pulmonaire par thoracoscopie : l'eskétamine était perfusée à faible dose, de l'induction jusqu'à quarante-huit heures après l'intervention. Le critère principal était une douleur persistante à la toux dans la région opérée, trois mois après l'intervention ; elle a concerné 14,7 % des patients sous eskétamine, contre 21,2 % sous sérum salé. Les scores de douleur des quarante-huit premières heures, au repos comme à la toux, ont eux aussi diminué, de même que le recours à des antalgiques supplémentaires, sans qu'un surcroît d'effets indésirables soit rapporté.

> **En pratique :** chez l'opéré d'une résection pulmonaire par thoracoscopie, une perfusion d'eskétamine à faible dose, commencée à l'induction et poursuivie quarante-huit heures, a ramené à **14,7 %** la douleur persistante à trois mois, contre **21,2 %** sous sérum salé, et abaissé les scores de douleur des deux premiers jours. Le critère principal retient toute douleur déclarée à la toux dès le premier échelon de l'échelle numérique ; les douleurs plus marquées ne sont éclairées que par une définition post hoc, à partir d'un score de **3**, qui n'avait pas été prévue. Le schéma d'administration, en trois temps, dont deux jours de perfusion postopératoire, suppose une organisation qui n'est pas celle de toutes les équipes. L'eskétamine peut donc se discuter chez l'opéré thoracique le plus exposé, en attendant un essai qui précise la dose utile et le seuil de douleur à retenir.

Article original

ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE & DOULEUR Méta-analyse bayésienne

Regional analgesic techniques for postoperative pain after kidney transplantation: a systematic review and Bayesian meta-analysis

Br J Anaesth · 27 octobre 2026 · 14 essais randomisés, 903 participants

La douleur après transplantation rénale est souvent intense, et la fonction du greffon limite le recours aux antalgiques par voie générale. Les synthèses précédentes mêlaient les techniques, confondaient donneurs et receveurs et ne se référaient à aucun seuil de pertinence clinique. Cette méta-analyse bayésienne a réuni quatorze essais randomisés, soit 903 receveurs adultes, et rapporté chaque résultat à une différence minimale jugée cliniquement importante. Seuls le bloc du carré des lombes et le bloc des muscles transverses de l'abdomen ont pu être regroupés face à un groupe témoin : tous deux abaissent les scores de douleur, mais, pour aucun des deux comparé au témoin, la probabilité de dépasser le seuil de pertinence retenu pour la douleur n'atteint 80 %. C'est seulement sur l'épargne morphinique que la réduction obtenue a une forte probabilité d'être cliniquement importante.

> **En pratique :** après transplantation rénale, un bloc du carré des lombes ou un bloc des muscles transverses de l'abdomen fait économiser une dizaine à une quinzaine de milligrammes d'équivalents morphine sur les premières vingt-quatre heures, et c'est le seul bénéfice dont l'importance clinique soit probable. Sur les scores de douleur, les deux blocs font mieux que le témoin, mais la probabilité que le gain dépasse le seuil de pertinence retenu n'atteint pas **80** % : son importance clinique n'est pas établie, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit exclue. Rien ne permet de préférer un bloc à l'autre : autant s'en tenir à celui que l'équipe maîtrise. Deux réserves de poids : le niveau de preuve est très faible, et l'effet sur la fonction du greffon reste inconnu — alors que c'est justement cette fonction qui fait chercher à épargner les antalgiques par voie générale.

Article original

ANESTHÉSIE PÉRIOPÉRATOIRE Essai randomisé de non-infériorité

Effect of remimazolam versus propofol anaesthesia on postoperative delirium in neurovascular surgery: a randomised noninferiority trial

Br J Anaesth · 29 octobre 2026 · Essai randomisé monocentrique en double aveugle, 686 patients analysés

En neurochirurgie vasculaire, le monitorage neurophysiologique peropératoire limite le recours aux halogénés et fait du propofol l'agent habituel, au prix d'une hypotension et d'un réveil parfois retardé après une perfusion prolongée. Le rémimazolam, benzodiazépine antagonisable par le flumazénil, a été associé à moins d'hypotension peropératoire que le propofol, mais sa classe fait craindre un surcroît de delirium postopératoire. Cet essai a comparé deux anesthésies totales intraveineuses, l'une au rémimazolam antagonisé par le flumazénil au réveil, l'autre au propofol, chez l'adulte relevant d'une neurochirurgie vasculaire programmée : clippage d'anévrisme intracrânien, résection de malformation artérioveineuse, décompression microvasculaire ou pontage entre artère temporale superficielle et artère cérébrale moyenne. Sur le critère principal, la fréquence du delirium des cinq premiers jours, le rémimazolam a satisfait le critère de non-infériorité fixé d'avance, sans que l'essai établisse pour autant une fréquence identique ; la charge hypotensive a été plus faible et l'extubation au bloc plus fréquente, deux critères secondaires.

> **En pratique :** en neurochirurgie vasculaire programmée, une anesthésie intraveineuse au rémimazolam antagonisé au réveil a laissé la fréquence du delirium des cinq premiers jours dans la marge de **10** points fixée d'avance, avec une charge hypotensive plus faible et une extubation au bloc bien plus fréquente — deux critères secondaires. Le surcroît de delirium que faisait craindre la classe des benzodiazépines ne se matérialise pas en un excès démontré — le delirium a été un peu plus fréquent sous rémimazolam, sans que la différence soit concluante —, mais l'essai ne montre pas pour autant que les deux agents se valent sur ce critère : l'intervalle de confiance laisse place à quelques points de delirium en plus. Dans ce type de chirurgie, où l'anesthésie intraveineuse est de règle, le rémimazolam devient une option défendable lorsque l'hypotension peropératoire est le souci principal. Trancher la question du delirium demanderait un essai plus grand, avec une marge plus étroite, et une confirmation dans d'autres centres.

Article original

VENTILATION, SDRA & OXYGÉNATION Essai randomisé en grappes

Chlorhexidine within a standardized oral-care bundle for the prevention of ventilator-associated pneumonia: a pragmatic cluster-randomized crossover trial in six medical intensive care units

Crit Care · 29 octobre 2026 · Essai randomisé en grappes avec permutation, 1 035 patients, six réanimations d'un même hôpital

La chlorhexidine figure depuis longtemps dans les protocoles de soins de bouche destinés à prévenir la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, mais son bénéfice a été remis en question hors de la chirurgie cardiaque. Cet essai pragmatique a comparé un protocole de soins de bouche standardisé avec et sans chlorhexidine à 0,12 %, dans six réanimations médicales d'un même hôpital universitaire, chaque service appliquant l'une puis l'autre stratégie pendant neuf mois. Sur le critère principal — la densité d'incidence des pneumopathies — l'ajout de chlorhexidine n'a apporté aucune réduction : l'estimation ajustée penche même légèrement en défaveur de l'antiseptique, sans que la différence soit significative. La mortalité à vingt-huit jours n'a pas différé non plus et, parmi les critères secondaires, le séjour en réanimation a été un peu plus long dans le bras avec chlorhexidine.

> **En pratique :** ajouter de la chlorhexidine à un protocole de soins de bouche déjà bien conduit n'a fait baisser ni les pneumopathies acquises sous ventilation ni la mortalité, et le séjour en réanimation a même été un peu plus long avec l'antiseptique, sur un critère secondaire dont l'interprétation reste ouverte. Le résultat rejoint les travaux récents qui ont fait douter de cette habitude hors de la chirurgie cardiaque, même si un essai mené dans un seul hôpital, sans calcul d'effectif préalable, ne tranche pas à lui seul. Il ne remet pas en cause les soins de bouche, standardisés et multimodaux dans les deux bras : c'est l'antiseptique ajouté par-dessus qui n'apporte aucun bénéfice démontré. Dans un service qui l'emploie encore par habitude, c'est un argument de plus pour porter l'effort sur la qualité du brossage et de l'aspiration plutôt que sur le bain de bouche.

Article original

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.